PREVALENCE, PROFIL CLINIQUE ET FACTEURS ASSOCIES AUX CARDIOPATHIES CONGENITALES DECOUVERTES EN PÉRIODE NEONATALE DANS LE SERVICE DE PEDIATRIE DU CHU-B DE SEPTEMBRE E DECEMBRE 2022 A OUAGADOUGOU AU BURKINA FASO

OUEDRAOGO Paul[1], ACHIDI Erica épouse Atemnkeng[2], SEGHDA T.A Arthur[3], DAO Lassina[4], OUEDRAOGO/YUGBARE Solange[2,3]

1. Université Saint Thomas d'Aquin
2. Université Joseph Ki Zerbo
3. Centre Hospitalier Universitaire de Bogodogo
4. Université Joseph KI Zerbo ; Centre Hospitalier Universitaire de Tengandogo

PLAN

- INTRODUCTION
- OBJECTIF
- MATERIEL ET METHODE(S)
- RESULTATS
- CONCLUSION

INTRODUCTION

- Cardiopathies congénitales (CC) → anomalies cardiaques survenant au cours de la formation du cœur pendant la vie intra-utérine
- Incidence au **BF** → 9/1000 NV
- **KINDA G** → 0,98 % des 11169 entrées au CHUP CDG
- **YAMEOGO NV** (2022) → 66/93 cas soit 71% de CC

OBJECTIF

- **Objectif Général** :

Etudier la prévalence et les facteurs associés aux cardiopathies congénitales découvertes en période néonatale dans le service de pédiatrie du CHU-B

OBJECTIF

❑ Objectif Spécifiques:

- Déterminer la prévalence des CC dans le service de pédiatrie du CHU-B de septembre 2022 à décembre 2022.
- Enumérer les différents types des CC diagnostiqués dans le service de pédiatrie du CHU-B de septembre 2022 à décembre 2022.
- Apprécier le profil clinique des nouveau-nés porteurs des CC dans le service de pédiatrie du CHU-B de septembre 2022 à décembre 2022.
- Analyser les facteurs associés aux cardiopathies congénitales dans le service de pédiatrie du CHU-B de septembre 2022 à décembre 2022

Matériel et méthode(s)

- **Cadre d'étude**

Le service de pédiatrie du CHU-B

- **Type et période de l'étude**

Il s'est agi d'une étude transversale à visée descriptive et analytique, avec recueil des données prospectives, allant du 1er septembre au 31 décembre 2022.

- **Population d'étude**

Enfants de âgés de 0 à 28 jours ayant consulté ou ayant été hospitalisés dans le service de pédiatrie de CHU- Bogodogo pendant la période de l'étude.

Matériel et méthode(s)

- **Critères d'inclusion**

Ont été inclus dans l'étude, tous les NN présentant une détresse respiratoire et qui ont effectivement réalisé une échographie cardiaque pendant la période de l'étude et dont les parents étaient consentants.

- **Critères de non-inclusion**

N'ont pas été inclus dans l'étude, les nouveau-nés qui sont décédés avant un diagnostic échographique de certitude et une collecte intégrale des variables.

Matériel et méthode(s)

Analyse et traitement des données

Les données ont été saisies sur un micro-ordinateur à l'aide du logiciel kobotool box. Le traitement des données collectées et l'analyse descriptive ont été réalisés à l'aide du logiciel STATA. Le test statistique utilisé a été le Chi carré pour l'analyse des variables. La signification statistique a été établie à $p<0,05$.

Considérations éthiques et déontologiques

L'autorisation de collecte auprès de l'administration et du chef de service du CHU-B obtenue, et le consentement du parent ou d'un tuteur légal

Résultats

❑ Données épidémiologiques

➢ **Fréquence** = **31.9%** (N = 172)

➢ **Sex-ratio** = **1.26**

- Féminin = **44.2%%** (76)
- Masculin = **55.8%** (96)

Résultats

❑ Données épidémiologiques

- **Age moyen des mères** = **29.51±6.17ans**]16- 46]

  = **[30-35] +++**

  = 12 (6.98 %) <20 ans

- **Profession des mères** = **69,7%** FAF

- **Age gestationnel prématuré** = 35 (**20.3%**)

  = **AG moyen 33.11±2.3**

Résultats

Aspects cliniques

Echocardiographie fœtale de dépistage prénatal	0%
Mères ayant bénéficiés de 4 visites prénatales	63,95%
Consanguinité	2,9%
Score APGAR 1 et 5 min ≥7	76,16% ; 90,7%
FPN	**30%**
NN réanimés à la naissance	**44,2%**
Cyanose à la naissance	**46 (26,7%)**

Résultats

- **Aspects cliniques** : malformations congénitales associées à la CC

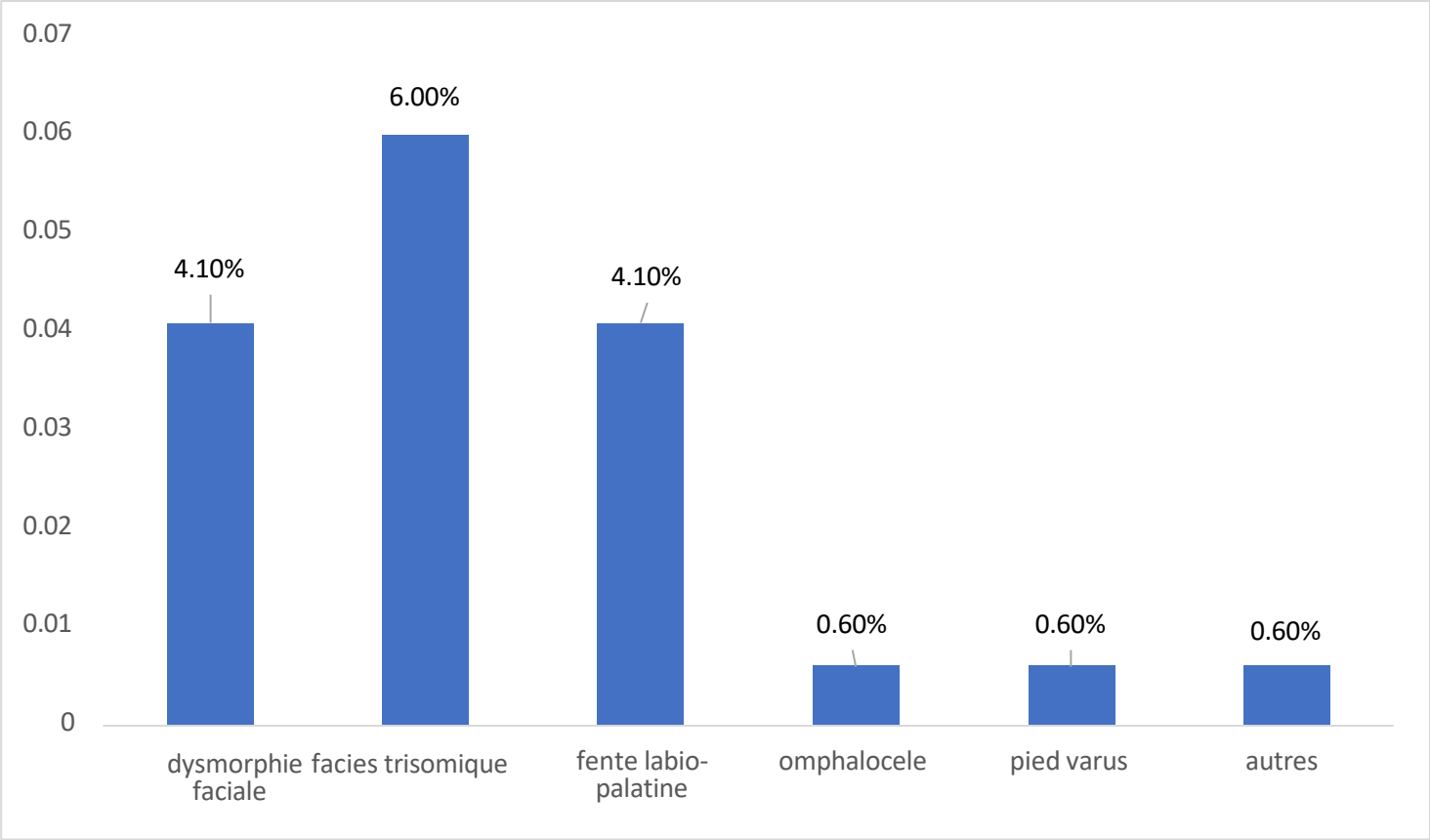

Figure 1 : Malformations associées

Résultats

Tableau I : Répartition des Cardiopathies retrouvées

Type de cardiopathies	Effectif	Pourcentage
CIA	46	83.6
CIV	14	25.45
CAV	**3**	5.4
T4F	2	3.6
APSO	1	1.8
Oreillette Unique	1	1.8

Résultats

Tableau II : Répartitions des associations des cardiopathies (n=9)

Cardiopathie Associe	Effectif	Pourcentage
CIA + T4F	1	11.1
CIA + CIV	6	66.6
CIA + CAV	1	11.1
CIV + Oreillette Unique	1	11.1
Total	**09**	**100**

Résultats

❑Aspects cliniques

- ➢CC cyanogènes 3.6%
- ➢CC non-cyanogènes 96.3% (dont 83,6% CIA)

NB : Le **taux de mortalité 5.45%** et certains NN ont été référés en chirurgie.

Résultats

❑Signes paracliniques

➢Signes radiologique

- ✓ Cardiomégalie était le signe radiologique 88.9%
- ✓ Pneumopathies interstitielles et alvéolaire 50% et 44.1%
- ✓ Bronchopathies 29.4%

➢**A l'échodoopler :** persistance du canal artériel (PCA) 39.1%

Résultats

- **Antécédents personnels prédictifs de la cardiopathie congénitale**
  - **L'âge maternel avancé, l'infection par la toxoplasmose, l'infection par la rubéole et la consanguinité** étaient tous associés de manière significative au développement d'une cardiopathie congénitale (p=0.001)
  - Prévalence de la cardiopathie s'est avérée plus élevée chez les NN ayant un **souffle cardiaque** (84.85%) par rapport aux nouveau-nés qui ne présentaient pas de souffle (19.42%). La différence était statistiquement significative (OR = 23.22, IC à 95 % = 8.20 – 65.73. P=0,001).

Résultats

- **Antécédents personnels prédictifs de la cardiopathie congénitale**

Tableau III : Maladies non-infectieuses maternelles

Variables	CC absents n (%)	CC présent n (%)	OR (95%CI)	P-Value
HTA				
Non	115(69.28)	51(30.72)	4.5(0.80 – 25.4)	0.08
Oui	2(33.33)	4(66.67)		
Pre-éclampsie				
Non	113(68.07)	53(31.93)	1.06(0.18 – 6.0)	0.94
Oui	4(66.67)	2(33.33)		
Eclampsie				
Non	115(68.86)	52(31.14)	3.31(0.53 – 20.45)	0.19
Oui	2(40)	3(60)		

Résultats

❑Aspects cliniques

Tableau IV : signes cliniques retrouvés au cours du suivi (n=32)

Variables	Effectif	Pourcentage
Souffle Cardiaque	18	56.25
Détresse respiratoire	10	31.2
Cyanose	01	
Déformation thoracique	0	0
Hépatomégalie	0	0
Dénutrition	12	37.5
SPO2		
<60	0	0
60-90	09	28.1
>90	23	71.8

Conclusion

- Les CC chez les nouveau-nés au CHU de Bogodogo : forte dominance des shunts gauche-droite. Leur prise en charge reste limitée sur le plan thérapeutique et leur évolution marquée par une forte létalité.
- L'espoir repose sur la prévention et la PEC chirurgicale (CHU T) grâce à la collaboration internationale

Merci pour votre attention